Azienda Ospedaliera Logudoro e Turritano
Ospedale Santissima Annunziata del Monte - Trauma Center
SC Radiologia d'Urgenza e Interventistica
Direttore: Dott. Antonio Giuseppe Pintus
Guardia radiologica attiva H24 - DEA di II livello

Viale Italia 290
07100 Sassari
Radiologia PS: 079 2618450
Angiografia: 079 2618466
Fax 079 2618499
radiologia.urgenza@aolt.example.it

REFERTO TC POLITRAUMA (TRAUMA TOTAL BODY)

TC encefalo e rachide cervicale senza mdc, TC torace-addome-pelvi con mdc trifasica, TC encefalo di controllo, angiografia con embolizzazione

PAZIENTE (identificata in PS alle ore 23:05, già registrata come IGNOTA)

Cognome:	**MURA**	Nome:	**SERENA**
Nata a / il:	**Sassari - 30/07/1999**	Età:	**27 anni**
Residenza:	**Via Gramsci 48, 07041 Alghero**	Telefono:	**+39 340 6128843**
ID provvisorio PS:	**PS-IGN-0412**	ID anagrafico:	**AOLT-00918266**

Accettazione PS:	PS-2026-0458812
Scheda 118:	SS118-26-77104
Data/ora evento:	27/09/2026 ore 22:40 circa
Ingresso shock room:	27/09/2026 ore 23:02
Richiedente:	Dott.ssa Maria Grazia Atzeni (trauma leader)

TC total body: TCWB-26-0118450

TC encefalo controllo: TCE-26-0118457

C.F. M R U S R N 9 9 L 7 0 I 4 5 2 D

DATI CLINICI (TRAUMA TEAM)

Trauma maggiore: incidente stradale ad alta energia, passeggera di motociclo, sbalzata a distanza dopo urto con autovettura, casco integrale indossato. Trasportata dal 118 (MSA) con collare e tavola spinale. All'arrivo: Glasgow Coma Scale 13 (E3 V4 M6), PA 86/52 mmHg, FC 124 bpm, SpO2 93% in O2. eFAST eseguita dal Dott. Paolo Lai in shock room: versamento nello spazio di Morison e periplenico; sliding pleurico ridotto a sinistra. Emoglobina 8,9 g/dL, lattati 4,7 mmol/L, beta-hCG sierica negativa. Etanolemia 0,38 g/L; screening tossicologico urinario positivo per cannabinoidi; il compagno riferisce uso abituale di cannabinoidi.

IMPORTANTE - La paziente, Testimone di Geova, porta con sé disposizioni anticipate di trattamento (DAT) del 12/01/2025 con rifiuto di emotrasfusione di sangue intero ed emocomponenti, confermato verbalmente in shock room alla presenza della Dott.ssa Atzeni e del compagno sig. Matteo Solinas. Accetta l'uso di cell-salvage e di acido tranexamico. Per tale motivo il trauma team ha privilegiato il trattamento angiografico non operatorio. Allergie: FANS (orticaria da ketorolac); non note reazioni a mezzi di contrasto.

TECNICA E MEZZO DI CONTRASTO

TC multistrato 256 strati, protocollo politrauma aziendale. Encefalo e rachide cervicale senza mdc; torace-addome-pelvi in fase arteriosa (bolus tracking), portale a 70 s e tardiva escretoria a 5 min, con braccia sollevate per la sola acquisizione toraco-addominale. Mdc: iopamidolo 370 mgI/mL, 110 mL a 4 mL/s da accesso venoso 18G in v. antecubitale destra posizionato dall'inf. Ignazio Floris. TSRM: Fabrizio Usai, Roberta Sanna. Acquisizione con supporto dell'anestesista Dott. Giovanni Melis.

Confronto: RX torace e bacino in shock room del 27.09.26 (acc. RXS-26-0118441) ed eFAST. Precedente TC addome con mdc del 16 aprile 2022 eseguita presso il Poliambulatorio Nurra Diagnostica di Alghero per colica renale destra, visionata su PACS regionale: reperto di milza accessoria di 9 mm all'ilo splenico.

REPERTI

Encefalo e rachide cervicale

Focolaio lacero-contusivo frontale basale destro di 7 x 5 mm. Sottile falda di ematoma subdurale fronto-parietale destro, spessore massimo 3,5 mm, senza effetto massa; linea mediana in asse. Non fratture della volta e della base cranica. Rachide cervicale: allineamento conservato, non fratture; spazi prevertebrali nei limiti.

Torace

Fratture costali scomposte dal IV al VII arco sinistro sulla linea ascellare media, con volet costale tra V e VII costa. Pneumotorace sinistro anteriore di 14,5 mm; contusione polmonare del lobo inferiore sinistro. Non pneumomediastino. Aorta toracica regolare, senza segni di lesione intimale. Non versamento pericardico.

Addome e pelvi

Lacerazione splenica multipla con interessamento dell'ilo, con stravaso attivo di mdc in fase arteriosa che aumenta in fase portale (polo inferiore). Emoperitoneo moderato periepatico, perisplenico, nella tasca di Morison e nel cavo del Douglas (densità 52 UH). Lacerazione epatica del VI segmento di 24,5 mm di profondità, senza stravaso. Reni con regolare escrezione in fase tardiva, non lesioni delle vie escretrici. Pancreas, surreni e anse intestinali senza segni di lesione; non aria libera.

Scheletro assile e bacino

Frattura da compressione del soma di L1 con riduzione dell'altezza anteriore del 22%, muro posteriore integro (tipo A1 secondo AO Spine; colonna anteriore secondo Denis). Frattura composta della branca ileo-pubica destra, anello pelvico stabile (Tile A2). Articolazioni sacro-iliache congruenti.

Riepilogo lesioni e grading (inserito nel registro traumi dal TSRM F. Usai)

Distretto	Lesione	Classificazione	Gestione proposta
Milza	lacerazione con coinvolgimento ilare e stravaso attivo	AAST grado IV	angioembolizzazione urgente
Fegato	lacerazione VI segmento, profondità 24,5 mm	AAST grado II	trattamento conservativo
Torace sx	fratture IV-VII costa, volet, PNX anteriore	-	drenaggio pleurico (chirurgia toracica)
Encefalo	contusione frontale dx, ESD sottile	Marshall II	TC di controllo a 6 ore
Rachide	frattura L1 da compressione	AO Spine A1	corsetto, consulenza ortopedica
Bacino	frattura branca ileo-pubica dx	Tile A2	trattamento conservativo

CONCLUSIONI PRELIMINARI (COMUNICATE AL TRAUMA LEADER ALLE ORE 23:31)

Politrauma con lesione splenica AAST IV con sanguinamento attivo ed emoperitoneo moderato, in paziente emodinamicamente instabile che rifiuta le emotrasfusioni: indicazione ad angioembolizzazione splenica in urgenza. Associati pneumotorace sinistro con volet costale, contusione cerebrale frontale e falda subdurale destra senza effetto massa, frattura L1 stabile, frattura della branca ileo-pubica destra. Discusso direttamente con la Dott.ssa M. G. Atzeni, il chirurgo d'urgenza Dott. Lai e il radiologo interventista di reperibilità Dott. Nicola Porcu.

Il Medico Radiologo di guardia (referto preliminare)
Dott. Efisio Cossu

Sassari, 27/09/2026 ore 23:44

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ADDENDUM 1 - ANGIOGRAFIA ED EMBOLIZZAZIONE SPLENICA

Acc. angiografia:	ANG-26-0118466	Inizio procedura:	28/09/2026 ore 00:12	Operatore:	Dott. Nicola Porcu
Secondo operatore:	dott.ssa Irene Fadda (specializzanda)	Infermiere di sala:	Gavino Tola	Anestesista:	Dott. G. Melis

Accesso femorale comune destro ecoguidato, introduttore 5F. Arteriografia selettiva del tripode celiaco e dell'arteria splenica: conferma di stravaso attivo da ramo polare inferiore e pseudoaneurisma di 6 mm in sede ilare. Eseguita embolizzazione superselettiva del ramo polare inferiore con microspirali e embolizzazione prossimale dell'arteria splenica con plug vascolare 8 mm. Controllo finale: assenza di stravaso, perfusione splenica residua da collaterali pancreatici. Emostasi con dispositivo di chiusura percutanea. Fluoroscopia 11,2 min, PKA 48,7 Gy·cm². Rientro in Terapia Intensiva alle ore 01:20.

ADDENDUM 2 - TC ENCEFALO DI CONTROLLO (CONFRONTO CON TC DEL 27/09/2026)

Esame del 28.09.2026 ore 05:40 (acc. TCE-26-0118457), eseguito su richiesta del Dott. Davide Piredda (SC Anestesia e Rianimazione - Terapia Intensiva Generale). Rispetto all'esame d'ingresso: focolaio contusivo frontale basale destro sostanzialmente invariato (8 x 5 mm), con iniziale alone edematoso; falda subdurale invariata (3,6 mm). Non nuove raccolte ematiche. Non idrocefalo. **Quadro stabile.**

INFORMAZIONI DOSIMETRICHE (D.LGS. 101/2020)

Acquisizione	Accession	CTDIvol (mGy)	DLP (mGy·cm)
Encefalo + rachide cervicale	TCWB-26-0118450	52,4	1186
Torace-addome-pelvi (3 fasi)	TCWB-26-0118450	9,8	2276
Encefalo di controllo	TCE-26-0118457	50,9	871
Totale TC	-	-	4333

Dose efficace complessiva stimata (TC) 19,6 mSv; angiografia: v. addendum 1. Gravidanza esclusa prima dell'esposizione (beta-hCG del 27/09/2026 ore 23:09).

REFERTO DEFINITIVO

Si conferma il referto preliminare del Dott. E. Cossu, integrato con gli addenda. Esito della procedura: emostasi splenica efficace con conservazione parziale del parenchima. Il caso è stato discusso al trauma meeting del 28 settembre 2026. La madre della paziente, sig.ra Giovanna Pinna, informata dai sanitari della Terapia Intensiva con il consenso della sig.ra Mura; il compagno M. Solinas è indicato come persona di riferimento (tel. 347 5509261). La paziente, cameriera presso Hotel Baia di Porto Conte S.r.l., ha chiesto che non siano fornite informazioni al datore di lavoro.

Il Dirigente Medico Radiologo (validazione)
Dott.ssa Bianca Deiana
Referto preliminare: Dott. Efisio Cossu - Angiografia: Dott. Nicola Porcu

A.O. LOGUDORO E TURRITANO
RADIOLOGIA D'URGENZA
Dott.ssa BIANCA DEIANA
OMCeO SS n. 5127

Sassari, 28/09/2026

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
Dott. NICOLA PORCU
Ord. Med. SS n. 4682

Immagini di MURA SERENA: https://pacs.aolt.example.it/viewer?acc=TCWB-26-0118450

(1) Classificazioni: AAST Organ Injury Scale (revisione 2018) per milza e fegato; Marshall per la TC encefalo; AO Spine e Denis per il rachide; Tile per l'anello pelvico. Glasgow Coma Scale all'ingresso rilevata dal 118 e confermata in shock room.
(2) Referto preliminare trasmesso alle ore 23:46 alla SC Chirurgia d'Urgenza e del Trauma e alla Terapia Intensiva; telefonata di conferma ricevuta dall'inf. Lucia Manca.
(3) Le DAT della paziente sono depositate presso il Comune di Alghero; fiduciario indicato: il fratello, sig. Andrea Mura. Copia acquisita in cartella clinica n. 2026/014773.